

Patrz bez oceny — *protokół RCT-skuteczny*

Stopniowa ekspozycja na własne odbicie. Cel: opis bez oceny. RCT-skuteczne dla nadwartościowania (Vocks 2007; Hildebrandt 2012). 6–12 sesji po 15–30 min.

CZAS: 15–30 min na sesję × 6–12 sesji

REALIZACJA: faza 2 CBT-E, po identyfikacji body checking/avoidance

ŹRÓDŁO: Hildebrandt, Loeb, Troupe & Delinsky (2012, *Behav Res Ther*); Vocks i in. (2007); Key i in. (2002); Morgan & Reid (2017, RCT meta)

JAK UŻYWAĆ

Sekcja 01 — **różnica między „patrzeniem-z-checking” a „patrzeniem-z-akceptacją”** + warunki protokołu (czas, miejsce, instrukcje). Sekcja 02 — **osiem kroków protokołu**. Sekcja 03 — **karta sesji** do wypełnienia po każdej ekspozycji.

DLACZEGO TO DZIAŁA

Mirror exposure — kontrolowana ekspozycja na własne odbicie w warunkach *opisu bez oceny*. Pacjent staje przed lustrem (15–30 min na sesję, 6–12 sesji łącznie) i *opisuje* swoje ciało *neutralnie* — bez słów wartościujących („gruby”, „chudy”, „brzydki”), bez fokusowania na „problematycznych miejscach”, obejmując całe ciało (nie wybiórczo). Mechanizm: habituacja lęku + dekateryzacja oceny. RCT (Vocks i in., 2007; Hildebrandt i in., 2012; meta-analiza Morgan & Reid, 2017): mirror exposure *znacząco* redukuje nadwartościowanie kształtu i wagi w AN i BN. Skuteczność porównywalna z całym CBT-E w tym wymiarze. Dlatego — to nie „dodatkowa technika”, lecz *kluczowa interwencja* dla pacjentów z wysokim body checking/avoidance.

01 Patrzenie-z-checking vs patrzenie-z-akceptacją

BODY CHECKING (SZKODLIWE)

Selektywne, oceniające, kompulsywne. Fokus na „problematyczne miejsca” (brzuch, uda, ramiona). Pomijanie reszty. Słowa: „gruby”, „brzydki”, „nie do zniesienia”. Określone pozycje, oświetlenie. Cel: ocena → niepokój.

MIRROR EXPOSURE (TERAPEUTYCZNE)

Pełne, opisowe, planowe. Całe ciało, od głowy po stopy. Opis *neutralny*: „jasne włosy, ramiona szerokie na X cm, klatka piersiowa, brzuch płaski/zaokrąglony, biodra...”. Bez słów wartościujących. Cel: opis → habituacja.

Kluczowa różnica — checking *wzmacnia* nadwartościowanie (każde sprawdzenie zwiększa wagę domeny „ciało” w samoocenie). Mirror exposure *redukuje* nadwartościowanie (powtarzana neutralna ekspozycja wygasza emocjonalną reaktywność na ciało).

Warunki protokołu: lustro całkowite (nie selfie), w białej bieliźnie lub stroju kąpielowym, dobre oświetlenie, 15–30 min, pacjent samodzielnie (po nauce z terapeutą), 1–2 sesje tygodniowo, łącznie 6–12 sesji.

02 Osiem kroków protokołu mirror exposure

1. **Wprowadzenie + zgoda** — „Mirror exposure to RCT-skuteczna technika dla AN. Wymaga 15–30 min × 6–12 razy. Trudna na początku, skuteczna po kilku sesjach”. Pacjent rozumie, że to *nie* jest „karanie” ani „upokorzenie”.
2. **Pierwsza sesja — w gabinecie terapeutycznym** — terapeuta z pacjentem (jeśli to akceptowalne) lub pacjent sam w pokoju z terapeutą za drzwiami. Nauka *metodyki* przed sesjami w domu.
3. **Pozycja i warunki** — lustro całkowite (drzwi, łazienka), bielizna lub strój kąpielowy (*nie* ubrana wersja), dobre oświetlenie, 1.5–2 metry od lustra, stojąc swobodnie.
4. **Reguły opisu** — opis *neutralny*, od głowy do stóp, *cały* obszar (nie pomijać), bez słów wartościujących, bez fokusowania. Forma: „widzę X, widzę Y”, nie „X jest brzydkie”.
5. **Czas — 15–30 min** — początkowo 15 min (lęk zwykle nieznośny dłużej), stopniowo do 30 min. SUDS notowany co 5 min. Oczekiwany przebieg: szczyt SUDS w 10–20 min, potem spadek.
6. **Zakaz checking-zachowań** — w trakcie sesji *nie*: zmiana pozycji „żeby sprawdzić”, napinanie brzucha, dotyk, łapanie się za fałdki. Stoisz spokojnie, opisujesz, czas mija.
7. **Powtarzanie 1–2 × tydz.** — po nauce w gabinecie pacjent kontynuuje w domu. Każda sesja: opis, SUDS, czas. Przegląd na sesji terapeutycznej.
8. **Spadek SUDS po sesjach 3–5** — to typowy przebieg. Po 6–8 sesjach SUDS początkowy spada z 8 → 4. Po 12 sesjach lustro przestaje wywoływać silną reakcję — habituacja osiągnięta.

03 Karta sesji mirror exposure — wypełnij po każdej

SESJA	DATA, CZAS TRWANIA	SUDS START	SUDS SZCZYT	SUDS KONIEC	UWAGI (OPIS-BEZ-OCENY, JAKIEŚ CHECKING)
1					
2					
3					
4					
5					

Klucz: mirror exposure jest jedną z *najbardziej* przewidywalnie skutecznych interwencji w pracy nad nadwartościowaniem ciała (RCT Vocks 2007, Hildebrandt 2012; meta Morgan & Reid 2017). *Trudna* na początku — wymaga psychoedukacji, zgody i opracowanego protokołu. *Skuteczna* w ciągu 6–8 sesji u większości pacjentów. Komunikat dla pacjenta: „to *nie* jest „kara”. To *trening* — uczysz się patrzeć na siebie bez oceniania. Pierwsze sesje są trudne. Po 5–6 razach widzisz różnicę”.

⚠ **Kontrowersje u pacjentów w skrajnym wyniszczeniu:** u pacjentów z BMI <14 mirror exposure może wywoływać silny dystres ze względu na realne objawy (obojczyki, żebra). Niektórzy klinicyści odraczają mirror exposure do BMI >15.5. Inni: prowadzą równolegle z rehabilitacją, z założeniem, że budujemy nowe doświadczenie ciała w trakcie zmiany. Wybór wymaga oceny klinicznej i konsultacji z zespołem.